

Fecha Última Actualización: 21-05-2024 16:12:33

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Veronica Paola Hernandez Santoro
Edad : 51a 0m 8d
Dirección : Pje Volcan Antuco 01280

Rut : 12.623.928-9
Fecha Nacto: 13/05/1973
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0334334
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 4231 9295

N° Epicrisis
399741

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto
Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 20/05/2024 05:57
Fecha Egreso : 21/05/2024 16:05

Días Estadía : 1

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

dificultad respiratoria

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: Verónica Paola Hernández Santoro
RUT: 12623928-9
Edad: 51 años
FI CASR: 20/05/24
FI UPC: 20/05/24
Contacto: 942318295, Catalina Barahona (nuera)

Antecedentes

AM: Mieloma múltiple en 2° línea de tratamiento, ERC etapa V sin HD

AQ: Fijación de columna por fracturas en hueso patológico

Medicamentos: Aspirina 100 mg/día, Bicarbonato de sodio 1 gr cada 8 horas, EPO 4000 UI 2 veces/semana, omeprazol 20 mg/día, Alopurinol 100 mg/día. Esquema con bortezomib 1.9 mg (7ma dosis 14/05/24)

Alergias: (-)

Resumen historia:

Paciente con antecedentes descritos, consulta por cuadro de 3 días de evolución de mialgias, CEG, disnea y tos productiva sin expectoración. Desde hace 24 horas con progresión de disnea hasta el reposo, por lo cual consulta en APS; desde donde es derivada por requerimientos de O2.

A su ingreso en regulares condiciones generales, taquicárdica, taquipneica. Se realizó TAC de tórax que mostró neumonía multifocal y panel respiratorio positivo para influenza A.

Se inició manejo con cobertura antibiótica empírica en espera de resultados de cultivos. Paciente evoluciona con empeoramiento de la mecánica ventilatoria, por lo que se decide manejo avanzado de vía aérea y conexión a VMI con parámetros protectores.

Posterior a intubación, evoluciona con deterioro hemodinámico por lo que se decide apoyar con NAD a dosis moderadas.

Paciente ingresa a UPC para continuar manejo.

Examen físico al ingreso

General: tibia a distal, llene capilar >3 segundos, SAS 1

Cuello: yugulares no ingurgitadas

Pulmonar: MP (+), disminuido globalmente, crepitaciones finas bibasales.

Fecha Epicrisis : 21/05/2024 16:12

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 21-05-2024 16:12:33

Página 2 de 3

Cardiaco: RR2TNAS

Abdomen: RHA disminuidos, abthera in situ.

EEII: T° conservada en ambas extremidades, sin livideces, sin edema.

Diagnósticos de ingreso:

1. Insuficiencia respiratoria aguda grave
2. Neumonía adquirida en la comunidad ATS IV
- a. Influenza A
3. Obs neutropenia febril
4. Insuficiencia renal aguda sobre crónica
- a. Obs lisis tumoral
5. Antecedentes

Evolucion en UCI:

HDN: inestable desde su ingreso. Se apoya con triple DVA en dosis muy altas, con respuesta parcial. Por sospecha de sepsis de foco respiratorio se decide conexion a HFAV. Tras 6 horas de terapia cursa con marcada hipotension que requiere aumento de DVA hasta NAD A 0.1, AD a 0.1 y vasopresina a 0.06 unidades. Se suspende terapia por considerarse futil. Paciente evoluciona con hipotension sostenida pese a desconexion de HFAV. Presenta AESP a las 15:25 horas. No se realizan maniobras de RCP por futilidad de estas. Paciente fallece a las 15:25 horas.

Respiratorio: cursando con insuficiencia respiratoria global, con requerimientos de FIO hasta 75%, se inicia BNM pero no ose prona dado inestabilidad hemodinamica. Pese a parametros de ventilacion protectora paciente mantiene ineficiencia ventilatoria.

Infeccioso: dado antecedentes de inmunosupresion se amplia esquema a imipenem + vancomicina. Se agrega oseltamivir dado panel respiratorio (+) para influenza A.

Hematologico: paciente con marcada pancitopenia en contexto de QMT reciente, no requirio transfusion de hemoderivados.

Renal: antecedentes de falla renal cronica que se exacerba durante estadia en UCI, a lo que se agrega posible sindrome de lisis tumoral con P hasta 15 y Ca 6.0. Por gravedad de paciente no se logra realizar HD.

Paciente con evolucion global desfavorable, fallece a las 15:25 horas.

Diagnóstico de Egreso

Shock septico - Foco pulmonar

Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) - Influenza A

Mieloma múltiple - En QMT de segunda linea

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallecido

Plan Post Alta

Paciente fallecido

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 21-05-2024 16:12:33

Página 3 de 3

INTERNO

Becado/Residente

Fabian Aguilera Mauna

Médico Tratante (Staff)